

ПРИКАЗЫ И ПИСЬМА В ИЗЛОЖЕНИИ ДЛЯ ЧАЙНИКОВ

Геморрагические лихорадки

Болезнь, вызванная вирусом Марбург: эпидемиология, суточная динамика геморрагического синдрома, дифференциальный ряд и режим санитарной охраны

Источник: информационные письма ГБУЗ «Станция скорой и неотложной медицинской помощи имени А. С. Пучкова» Департамента здравоохранения города Москвы № 1-14/594 от 28.02.2023 и № 1-14/3158 от 09.10.2024.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 30 сентября 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

О чём письма

Оба письма относятся к болезни, вызванной вирусом Марбург (БВВМ): письмо № 1-14/594 (2023) издано по сообщению Управления Роспотребнадзора о вспышке в Экваториальной Гвинее и Камеруне, письмо № 1-14/3158 (2024) — по письму Управления от 04.10.2024 № И-18-158/4 об эпидемической ситуации в Руанде. Поскольку болезнь и схема действий общие, материал объединяет оба письма.

Операционное правило: у пациента с лихорадкой, выраженной интоксикацией, головной болью, ознобом и миалгией уточняется выезд в зарубежные страны; геморрагические симптомы у прибывшего из неблагополучной страны — основание для режима приказа № 2710 от 10.11.2023.

Лихорадка Марбург как болезнь

Лихорадка Марбург — острое зоонозное вирусное заболевание из группы вирусных геморрагических лихорадок; возбудитель относится к семейству филовирусов, как и вирус Эбола. Резервуар — плотоядные летучие мыши. Передача от человека к человеку — при прямом контакте с биологическими жидкостями (кровь, слюна, рвотные массы, моча) или через заражённые предметы (инструменты, одежда); воздушно-капельный путь возможен при тесном взаимодействии.

Течение быстрое и агрессивное; смертность достигает 88 %. Специфического лечения и вакцины на момент писем не существует. Показательно, что во вспышке в Руанде более 70 % подтверждённых случаев пришлось на работников здравоохранения — болезнь избирательно поражает медицинский персонал, работающий без полного противоэпидемического режима.

Эпидемиологическая ситуация

- 2022 год — первая в истории Ганы вспышка БВВМ: 3 случая, 2 летальных.
- 2023 год — впервые подтверждена вспышка в Экваториальной Гвинее (9 летальных исходов, 16 подозрительных случаев) и 2 предполагаемых случая в Камеруне у границы с ней.
- 2024 год — Руанда: подтверждённые случаи, включая летальные, зарегистрированы в 7 из 30 округов; ВОЗ предупредила о высоком риске эпидемии.

Прямого авиасообщения между Россией и Экваториальной Гвинеей и Камеруном нет; прибытие возможно стыковочными рейсами через Каир, Касабланку, Аддис-Абебу, Стамбул, Дубай, Ереван, Ташкент и Баку — что и определяет необходимость анамнеза о транзите, а не только о стране назначения.

Клиническая картина

Инкубационный период 3–16 суток, максимум 21 сутки. Начало острое: высокая лихорадка в течение до 2 недель, выраженная интоксикация, головная боль, миалгии, боли в пояснично-крестцовой области; конъюнктивит, энантема и везикулёзно-эрозивные изменения слизистой рта, брадикардия, гипертонус мышц.

Сутки болезни	Характеристика
1–3	Лихорадка, интоксикация, головная боль, миалгии; конъюнктивит, энантема, брадикардия
3–4	Присоединяются рвота и водянистая диарея с быстрым обезвоживанием

Сутки болезни	Характеристика
5–6	Возможна макуло-папулёзная сыпь с последующим шелушением
6–7	Геморрагические проявления: кожные геморрагии, носовые, желудочно-кишечные и другие кровотечения; гепатит, миокардит, поражение почек; поражение ЦНС — заторможенность и менингизм
8–10 и 15–17	Периоды ухудшения состояния, иногда с летальным исходом

Реконвалесценция продолжается 3–4 недели и может сопровождаться длительной диареей, выраженной астенизацией, психическими расстройствами и выпадением волос. Дифференциальный ряд: болезнь дифференцируется с теми же заболеваниями, что и лихорадка Эбола, — другими геморрагическими лихорадками, лептоспирозом, тифопаратифозными заболеваниями, малярией, сепсисом, корью и менингококковой инфекцией.

Что предписано бригаде и диспетчерской

Кому	Предписание
Единая городская диспетчерская	При оформлении вызова к пациенту с лихорадкой, выраженной интоксикацией, головной болью, ознобом и миалгией уточнять выезд в зарубежные страны и вносить сведения в приложение к вызову
Выездной персонал	Настороженность в отношении геморрагических лихорадок при помощи пациентам с повышенной температурой и геморрагическими симптомами, прибывшим из неблагополучных стран; тщательный сбор эпидемиологического анамнеза
Заведующие и старшие врачи	При подозрении — неукоснительное соблюдение приказа № 2710 от 10.11.2023; доведение писем до персонала; прохождение образовательного курса по опасным инфекциям на портале Станции

Действия при подозрении

Подозрение формируется сочетанием лихорадки с геморрагическим синдромом (кожные геморрагии, носовые и желудочно-кишечные кровотечения) и пребыванием в неблагополучном регионе в пределах инкубационного периода — до 21 суток, включая транзит через перечисленные хабы.

При подозрении включается противоэпидемический режим приказа № 2710: работа в средствах индивидуальной защиты, изоляция пациента, дезинфекция, уведомление старшего врача смены и эвакуация в стационар инфекционного профиля.

Источники

- Информационные письма ГБУЗ «ССиНМП им. А. С. Пучкова» ДЗМ № 1-14/594 от 28.02.2023 и № 1-14/3158 от 09.10.2024.
- Письма Управления Роспотребнадзора по Москве от 22.02.2023 № 77000-18/ЭЦ-01-1013-2023 и от 04.10.2024 № И-18-158/4.
- Приказ ССиНМП им. А. С. Пучкова № 2710 от 10.11.2023.

Выходные данные

Геморрагические лихорадки · версия 1.0 · сентябрь 2026 · Серия «Крещение поворотом»
· CC BY-NC-SA 4.0. Материал носит справочный характер и не заменяет действующие
приказы и клинические рекомендации.

Нашли ошибку — напишите в «Обсуждениях» репозитория на GitHub.